

ITEM 273 : HEPATOMEGALIE ET MASSE ABDOMINALE

HEPATOMEGALIE

Hépatomégalie = augmentation du volume du foie : - **Diffuse** ou **portant sur un lobe ou un secteur**
- **Homogène** ou **inhomogène**

Diagnostic positif	Découverte	- Perception par le patient d'une masse de l'hypochondre droit et/ou de l'épigastre - Palpation par le médecin ou examen d'imagerie abdominale → Peut être rattaché à une hépatomégalie si la masse est mobile avec la respiration	
	Diagnostic positif	= Projection du foie sur la ligne médioclaviculaire > 12 cm - Distance entre la limite supérieure de la matité hépatique et le bord inférieur repéré à la palpation - Difficile à affirmer en cas de : paroi abdominale très musclée, défense, panicule adipeux sous-cutané abdominal très épais, ascite abondante → diagnostic positif et différentiel par échographie abdominale	
	DD	- Tumeur rénale, de l'angle colique droit, du colon transverse, de l'estomac, du pancréas (pseudokyste)	
Etiologie	Diffuse et homogène	- Hépatite aiguë - Hépatite chronique - Stéatose et stéato-hépatite : alcoolique, NASH - Cholestase prolongée - Cirrhose - Foie congestif : insuffisance cardiaque droite ou globale, péricardite constrictive - Hémochromatose ou surcharge en fer - Abcès du foie	
	Sectorielle et homogène	- Cirrhose principalement	
	Hétérogène	- Cirrhose - Tumeur bénigne : kyste biliaire simple, kyste hydatique - Polykystose hépatique ou hépatorénale - Abcès du foie - Tumeur maligne : métastase hépatique, carcinome hépatocellulaire, cholangiocarcinome	
Diagnostic étiologique	C	- Palpation : - Hépatomégalie diffuse ou sectorielle, homogène ou inhomogène, douloureuse ou non - Consistance : foie normal = ferme , foie cirrhotique = dur , surtout au bord inférieur (tranchant) - Recherche de signe inflammatoire (fièvre), de maladie hépatique chronique, d'hypertension portale, reflux hépato-jugulaire, expansion systolique du foie, élévation du pouls jugulaire	
	PC	Echo hépatique	= Indispensable : précise le caractère diffus/sectoriel, homogène ou non + signes étiologiques - Recherche de signe de cirrhose : contours irréguliers, signes d'hypertension portale - Recherche de signe de stéatose : foie hyperéchogène - Recherche de signes d'insuffisance cardiaque : dilatation des veines hépatiques et de la VCI - Recherche de signes de cholestase : dilatation des voies biliaires intra-hépatiques
		Biologie	- 1 ^{ère} intention : NFS, bilan hépatique (transaminases, PAL, TP, bilirubinémie), EPS - Suspicion de cirrhose : marqueurs d'hépatite virale, auto-immune, bilan martial - Hépatomégalie homogène avec anomalie du bilan hépatique : sérologie hépatite virale, bilan auto-immun, bilan martial - Nodule : αFP sérique - Abscès : sérologie amibiase, hémoculture - Kyste : sérologie échinococcose
		Imagerie	- En cas d'hépatomégalie homogène : échographie-Doppler, TDM/IRM injecté tri-phasique - En cas d'hépatomégalie hétérogène : échographie de contraste, TDM/IRM injecté tri-phasique - Echographie cardiaque si suspicion d'insuffisance cardiaque
		Ponction biopsie hépatique	→ Indispensable si bilan étiologique négatif (clinique, biologique et imagerie) - En tout point si hépatomégalie diffuse ou sur les lésions focales si hépatomégalie hétérogène - Par voie transpariétale trans-capsulaire , généralement écho-guidée , parfois par TDM (si lésion mal visible en écho) ou coelioscopique
	CI	- Trouble de l'hémostase non corrigé : thrombopénie < 60 G/L, TP < 50%, ↗ du TCA - Dilatation diffuse des voies biliaires intra-hépatiques - Ascite → En cas d'ascite ou de trouble de l'hémostase : PBH par voie trans-jugulaire	

Démarche diagnostique	Hépatomégalie diffuse et homogène	- Cirrhose : signes cliniques, biologiques et échographiques indiscutables d'insuffisance hépatique et d'hypertension portale + cause de cirrhose documentée - Stéatose ou stéato-hépatite : foie hyperéchogène + cause documentée (consommation excessive d'alcool ou syndrome métabolique) - Foie cardiaque : dilatation des veines hépatiques + atteinte cardiaque documentée (ETT) - Hépatite aiguë/chronique : anomalie du bilan hépatique + cause documentée (virale, auto-immune ou médicamenteuse) - Hémochromatose : hyperferritinémie (sans syndrome inflammatoire ni transaminases > 4N) → IRM - Cholestase chronique : ictère cholestatique ou dilatation des voies biliaires → Si aucun diagnostic ne peut être fait avec certitude : PBH		
	Hépatomégalie sectorielle homogène	- Cirrhose dans la majorité des cas : confirmé par la clinique, la biologie et l'échographie - Plus rarement : hépatomégalie sectorielle par réponse à une atrophie d'autres secteurs (par obstruction des voies biliaires, des veines hépatiques ou des veines portes)		
	Hépatomégalie hétérogène	→ Rechercher une maladie hépatique chronique : FdR, clinique, biologique, échographique		
		En cas de maladie hépatique chronique	- Rechercher un carcinome hépatocellulaire - Si dilatation des voies biliaires intra-hépatiques : cholangiocarcinome	
		En l'absence de maladie hépatique chronique	→ Selon l'échographie	
			Lésion kystique	- Kyste biliaire simple : vérifier l'absence de paroi ou cloison interne et le caractère purement liquidien ± Sérologie hydatidose si sujet ayant vécu en zone d'endémie au contact de chiens - IRM/TDM ou écho de contraste si doute à l'échographie - Si conditions non réunies : rechercher - Tumeur bénigne à potentiel malin ou tumeur maligne - Kyste hydatique - Kyste biliaire simple modifié par une hémorragie intra-kystique
			Lésion solide	→ Selon le contexte clinique (cancer extra-hépatique...) et la cinétique de rehaussement (IRM, TDM ou écho de contraste)
				Rehaussement en motte périphérique, progressif de la périphérie vers le centre, hyper-intensité homogène T2 Hémangiome bénin
				Rehaussement périphérique au temps artériel avec centre non rehaussé Abcès ou tumeur nécrosée (maligne ou bénigne) → Ponction de la zone nécrotique pour analyse microbiologique si syndrome inflammatoire marqué
				Absence de rehaussement au temps artériel et portal Métastase ou adénome hépatocellulaire → Bilan selon le contexte néoplasique
				Rehaussement net au temps artériel avec élimination du produit de contraste plus marquée dans le nodule que dans le foie adjacent au temps portal ou tardif (<i>wash out</i>) Carcinome hépatocellulaire
				Rehaussement net au temps artériel sans wash out Adénome, hyperplasie nodulaire focale, métastase ou tumeur primitive maligne (autre que CHC)

MASSE ABDOMINALE

Epigastrique	- Hypertrophie du lobe hépatique gauche	
	Tumeur gastrique	= Masse dure, pierreuse - Signes digestifs hauts : épigastralgie, lenteur à la digestion, AEG
	Tumeur pancréatique	= Masse dure, fixée, sensible - Cancer de la tête du pancréas : ictère prurigineux par compression de la VBP - Cancer du corps pancréatique : douleur type solaire - Cancer de la queue : révélation tardive par une masse épigastrique ou de l'HCG
	Pseudokyste du pancréas	= Tuméfaction régulière, ferme et rénitente
Hypocondre droit	- Hépatomégalie - Angle colique droit - Rein droit ou surrénale droite	
	Grosse vésicule	= Vésicule non palpable à l'état normal : masse au bord inférieur du foie, piriforme, mobile avec les mouvements respiratoires - Compression de la voie biliaire principale : cancer de la tête du pancréas ou de la VBP - Hydrocholécyste : calcul enclavé dans le collet ou dans le canal cystique - Cholécystite aiguë (rarement palpable) : douloureuse, fébrile - Tumeur maligne de la vésicule : masse dure, fixée, irrégulière
Hypocondre G	- Queue du pancréas - Angle colique gauche - Grosse tubérosité gastrique - Rein gauche	
	Splénomégalie	= Rate normalement non palpable : s'abaisse à l'inspiration, bord antérieur crénelé - Splénomégalie homogène : origine infectieuse, hémopathie, hypertension portale - Splénomégalie hétérogène : abcès, kyste hydatique, tumeur
Autres localisations	Fosse iliaque droite	- Tumeur du caecum : dure, mobile ou fixée ± caractère inflammatoire si tumeur infectée - Appendicite abcédée : tuméfaction douloureuse et fixée, dans un contexte fébrile - Maladie de Crohn avec abcès
	Fosse iliaque gauche	- Sigmoïdite avec abcès péri-sigmoïdien (rare) - Tumeur sigmoïdienne
	Hypogastrique	→ Eliminer en 1 ^{er} : grossesse, fécalome, globe vésical - Fibromyome utérin : masse régulière, bien limitée, ferme, indolore, d'origine utérine au TV - Cancer de l'endomètre - Tumeur ovarienne : masse latéralisée à droite ou à gauche
	Ubiquitaire	- Tuméfactions pariétales = mise en évidence lors de la contraction de la sangle abdominale : hématome de la paroi, lipome, hernie - Nodule de carcinose péritonéale : dur, indolore, fixé, souvent multiples, assez souvent situés en région péri-ombilicale ou au niveau d'anciennes cicatrices - ADP abdominale (palpable chez le sujet maigre) : bénigne, infectieuse ou maligne - Corps étranger (notamment chez sujet opéré)
	Lombaire	- Lésion rénale : tumeur maligne, hydronéphrose - Lésion surrénalienne : tumeur bénigne/maligne - Tumeur rétropéritonéale primitive : sarcome
	Ombilicale	- Anévrisme de l'aorte abdominal : tuméfaction médiane, battante, expansive avec un souffle systolique